

GASTRITES

Dr MHAMDIA A

Maitre assistante

Hépto-gastro-enterologie

- Plan

- I. Introduction

- II. Epidemiologie

- III. Diagnostic

- IV. diagnostic étiologique

- LES GASTRITES AIGUES :

- LES GASTRITES CHRONIQUES

- I.Classification

- 2.Etude des differentes formes

- LES GASTRITES CHRONIQUES À HELICOBACTER PYLORI (HP)

- LES GASTRITES CHRONIQUES NON LIEES A HP:

- A/Sans lésions spécifiques

- B/Avec lésions spécifiques

- VI. conclusion

I. INTRODUCTION

- Les gastrites sont des affections fréquentes, d'étiologies multiples
- Le terme de gastrite est réservé aux maladies inflammatoires de la muqueuse gastrique.

Le diagnostic de gastrite repose sur l'examen par l'anatomopathologiste des biopsies gastriques prélevées lors d'une endoscopie oeso-gastro-duodénale

Il n'y a pas de corrélation entre la clinique, l'aspect endoscopique et l'histologie.

II.EPIDEMIOLOGIE

- Fréquence: 75% après 50 ans.
- **Gastrites aiguës:**
rares en dehors des gastrites médicamenteuses aux AINS
- **Gastrites chroniques:**
 - la forme la + fréquentes
 - à Helicobacter Pylori dans 80% des cas
 - L'évolution vers le cancer gastrique est rare mais toujours possible et demeure la principale crainte du clinicien.

III.DIAGNOSTIC

- **A. CLINIQUE :**

- La symptomatologie clinique est variable selon l'étiologie et le caractère aiguë ou chronique de la gastrite.
- Souvent asymptomatique de découverte fortuite à l'endoscopie.
- Douleurs épigastriques, vomissements, intolérance alimentaire,
- Hémorragie digestive haute (gastrites aiguës).
- Syndrome dyspepsique : épigastralgies, inconfort gastrique, satiété précoce, éructations, mal digestion...
- *Tableau clinique particulier:* carence d'absorption de la vitamine B12 par diminution de la sécrétion du FI: anémie pernicieuse

- **B.ENDOSCOPIE DIGESTIVE HAUTE :**

- L'aspect endoscopique est non spécifique et ne permet pas de porter le diagnostic du type de gastrite

- permet de faire des biopsies + étude anatomopathologique

- Les aspects :

l'œdème

l'érythème

la fragilité muqueuse

les exsudats

les pertes de substances (érosion ou ulcère)

l'hyperplasie des plis fundiques

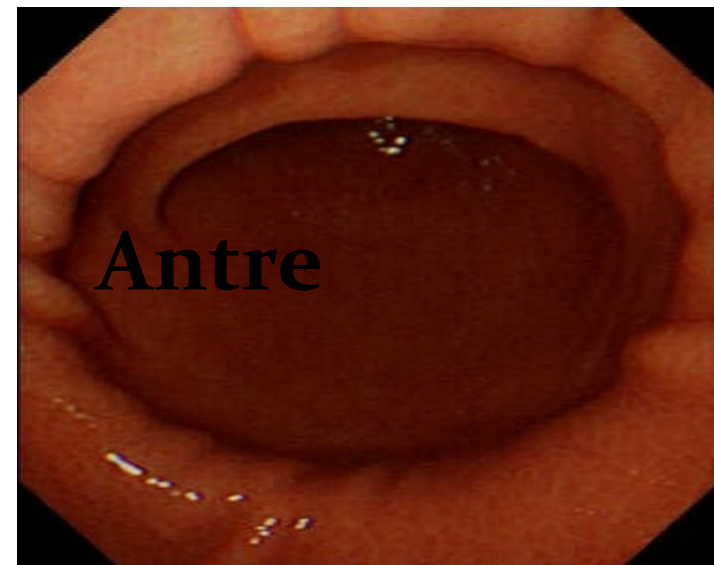
la visibilité des vaisseaux sous muqueux

les points hémorragiques (purpuriques ou ecchymotiques)

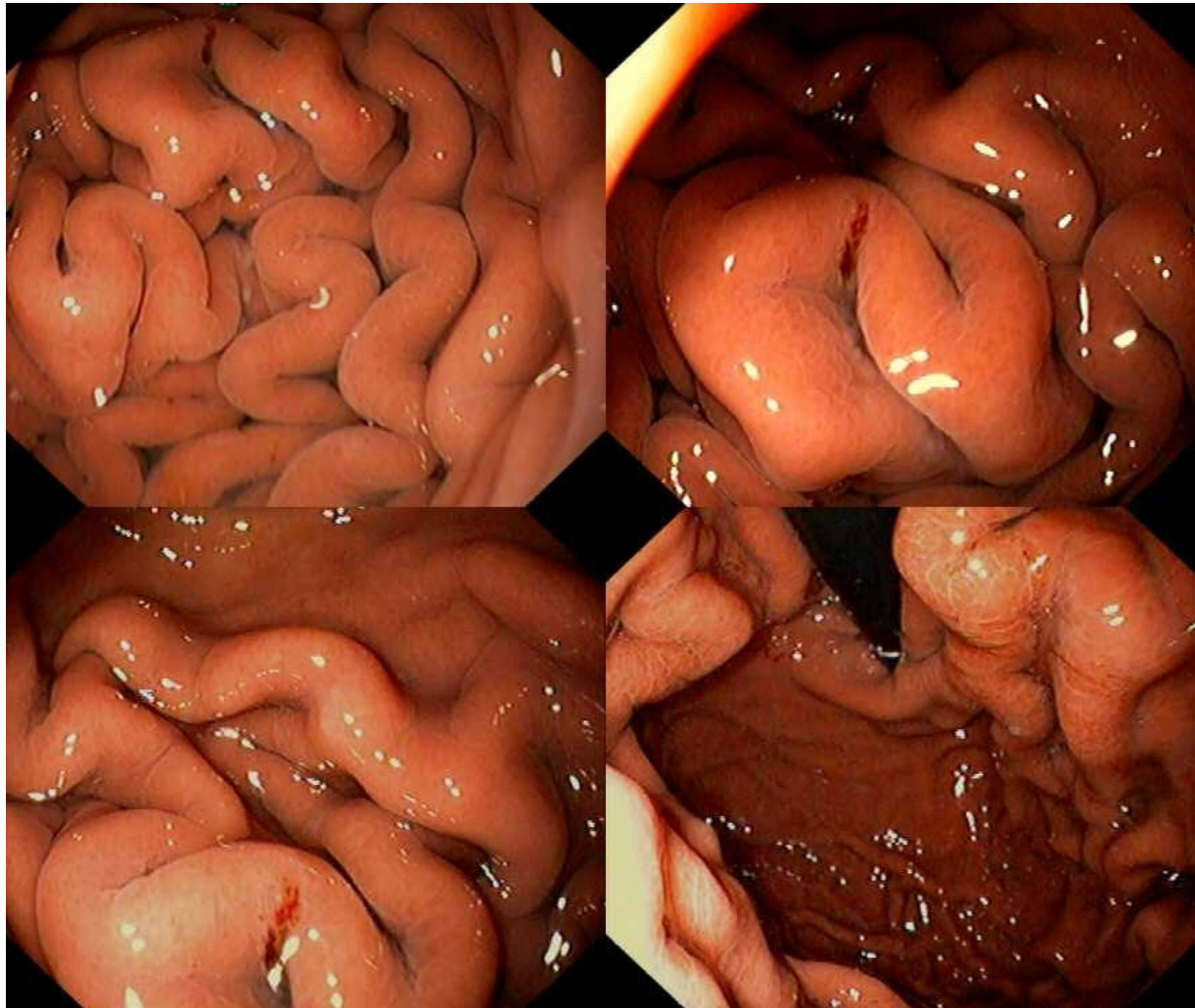
les nodules donnant un aspect pseudopolypoïde ou micronodulaire.

- Il existe une très mauvaise corrélation entre l'aspect macroscopique de la muqueuse gastrique et l'histologie

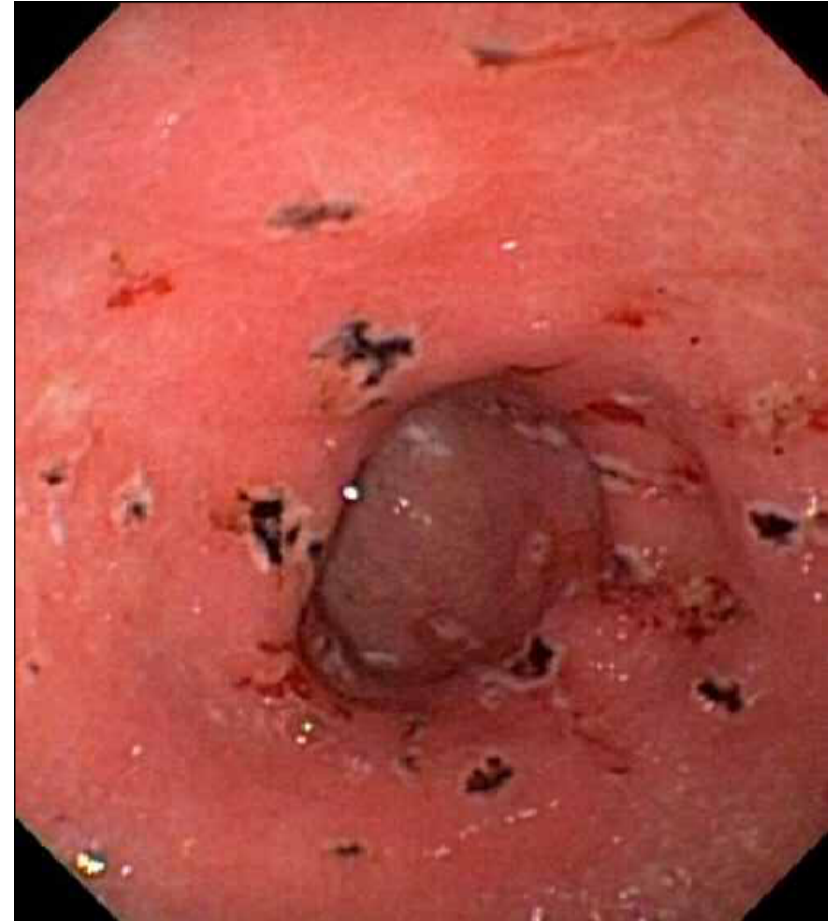
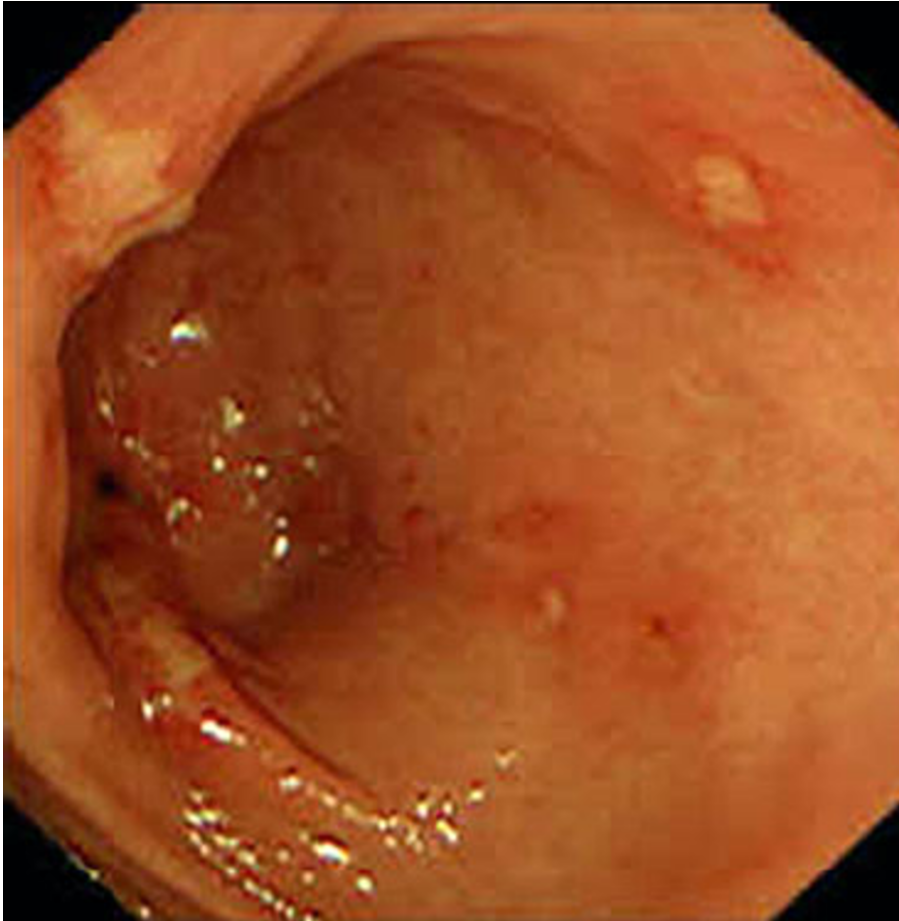
Muqueuse gastrique normale



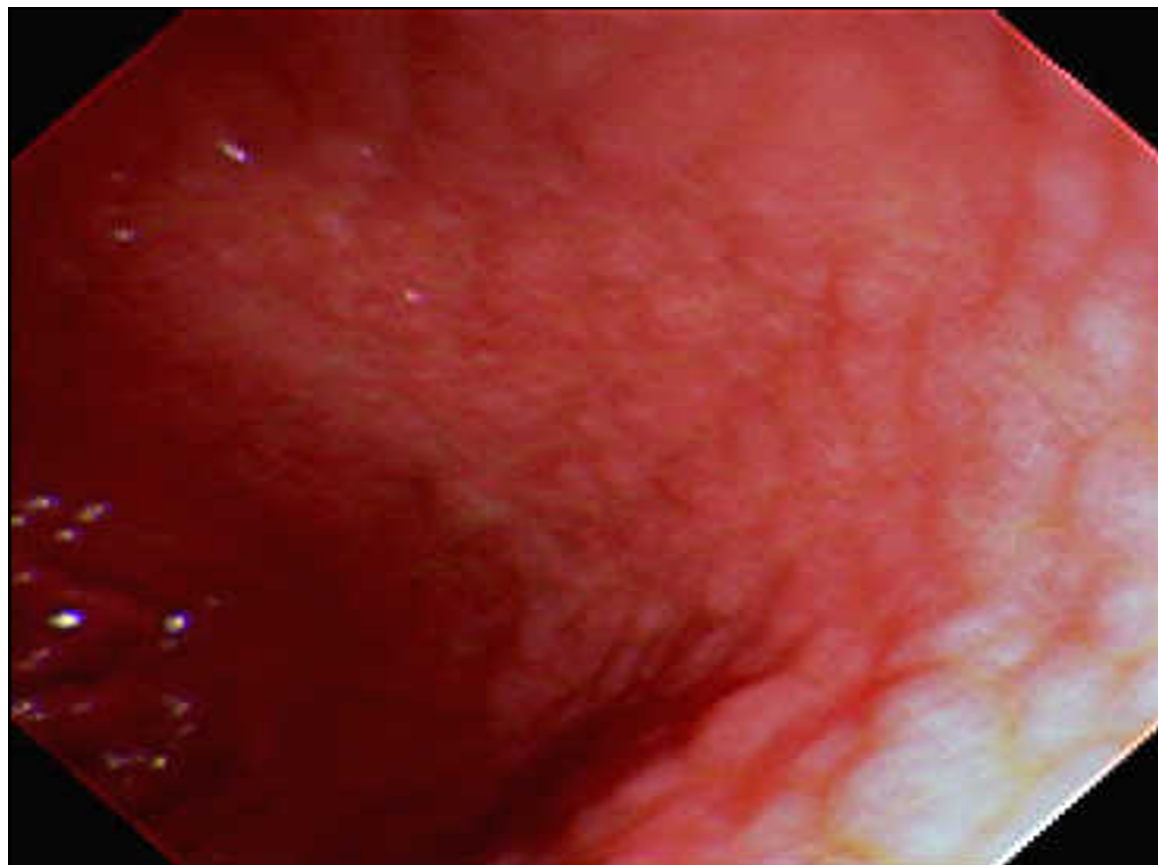
Muqueuse gastrique normale



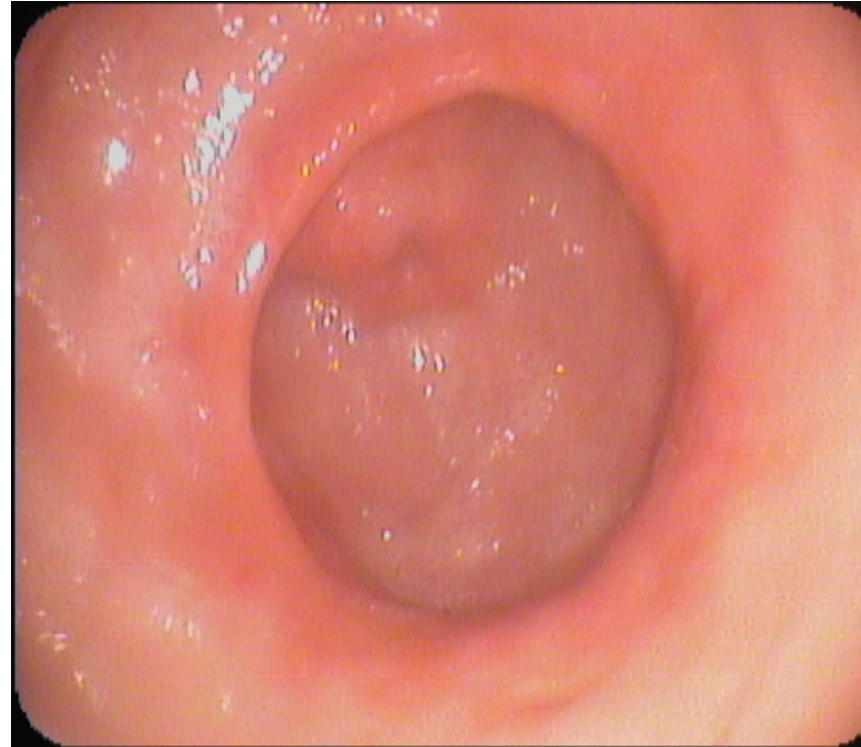
Gastrite érosive



Gastrite micronodulaire



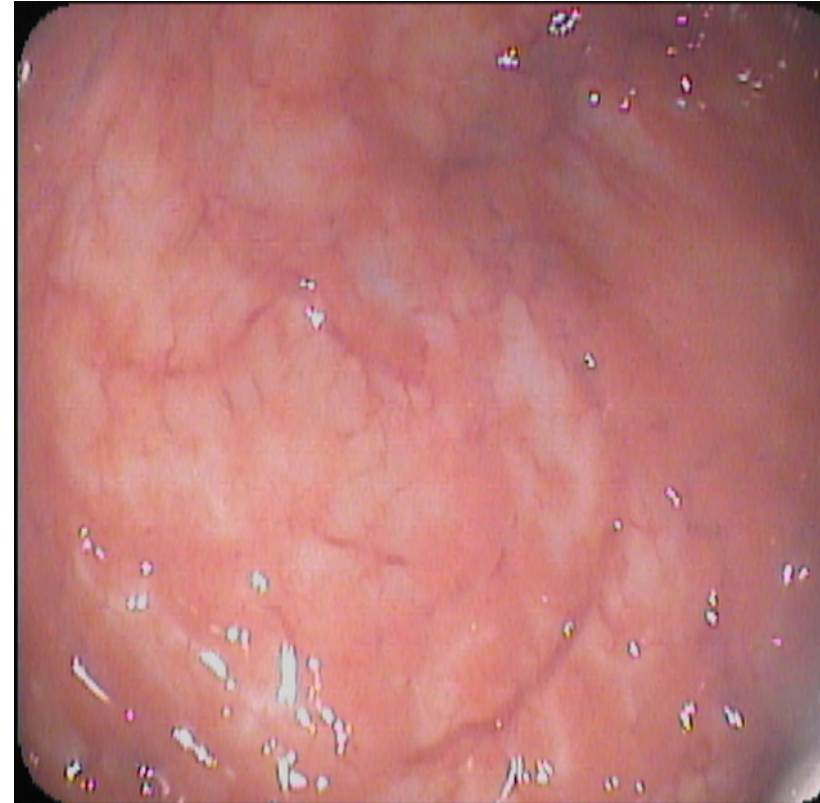
Gastrite antrale érythémateuse superficielle



Name: BENATTIG
ID: BENATTIG+AIS Age: 65 Sex: M
Comment: PR+AINS INJ+ASYPTQ

Doctor: SALAH
Date: 2005/07/09 19:10:12

Gastrite atrophique



Name: ANTRI
ID: ANTRI= AINS Age: 60 Sex: M
Comment: AINS=ATROPHIE GAST

Doctor: SALAH
Date: 2005/07/20 17:23:40

- **C. HISTOLOGIE :**

- permet de poser le diagnostic, de typer la gastrite et de rechercher l'étiologie.
- 05 éléments fondamentaux doivent apparaitre sur le compte rendu histologique
 - ✓ L'infiltrat lymphoplasmocytaire
 - ✓ la présence de PNN qui signe l'activité de la gastrite
 - ✓ l'atrophie glandulaire, légère , modérée ou sévère
 - ✓ la métaplasie intestinale
 - ✓ la dysplasie qui correspond à des lésions précancéreuses.
- + Recherche systématique de l'*Helicobacter pylori*

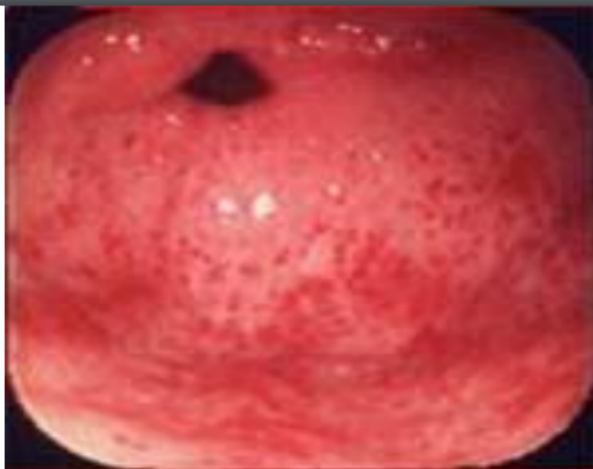
IV. DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE

1. LES GASTRITES AIGUES :

- Il s'agit d'une inflammation aiguë
- tous les stades de la congestion à la perte de substance peuvent être observés.
- Clinique:
 - Asymptomatique: 9/10
 - Épigastralgies, dyspepsie, hémorragie digestive.
- Endoscopie:

lésions diffuses et multiples :

 - œdème, lésions pétéchiiales et purpuriques
 - érosions superficielles
 - lésions ulcéronécrotiques.
- Complications: hémorragies et perforation.



Gastrite antrale érosive



**Gastrite fundique
érythémateuse**



Gastrite hémorragique

ETIOLOGIES

❖ Gastrites aiguës infectieuses

- Bactérienne: HP ++
autres bactéries: streptocoque, staphylocoque, E. coli, salmonelles...
(gastro-entérite)
Forme particulière: gastrite phlegmoneuse rare; (SIDA).
- Virale (CMV HSV); (SIDA),
- Parasitaire; Mycotique

❖ Gastrites aiguës iatrogènes

- AINS; Aspirine; Radiothérapie

❖ Gastrites aiguës de Stress

- État septique grave; État de choc;
- Polytraumatisé
- Brûlure étendue; Insuffisance viscérale

❖ Gastrites aiguës toxiques

- Alcool; Caustiques

TRAITEMENT

- Mesures d'urgence si nécessaire
- Anti sécrétoire = IPP/ anti H2 (peros /IV)
- TRT étiologique=
 - ✓ ATB
 - ✓ Arrêt substances gastrotoxiques
- Chirurgie = exceptionnelle
- Prévention : par IPP chez malades à risque

2. LES GASTRITES CHRONIQUES:

- Etat inflammatoire chronique de la muqueuse gastrique caractérisé par :
 - ❑ Infiltrat inflammatoire persistant
 - ❑ Prédominance lympho-plasmocytaire
 - ❑ $\pm$ altération de la cinétique et de la différenciation cellulaire
- C'est une Affection fréquente (30-50% de la population générale)
- Elles sont souvent asymptomatiques
- parfois peu symptomatique (inconfort gastrique, dyspepsie...).
- Le Principal agent causal est l'infection par l'hélicobacter Pylori « HP »
- C'est un état précancéreux dans certaines situations d'où l'intérêt de la surveillance
- Il existe 02 types évolutifs : les gastrites chroniques atrophiques (les plus fréquentes, exposant au cancer gastrique), et les gastrites non atrophiques.

- **I.CLASSIFICATION DES GASTRITES CHRONIQUES**

- **-Strickland et Mackay 1973 :**
- Gastrite chronique type A : fundique
- Gastrite chronique type B : antrale

Classification SYDNEY SYSTEM +++ Topographie; étiologie; morphologie

Deux partie : endoscopie ; histologie

Endoscopie:

- Topographie:

- ✓ Gastrite Antrale
- ✓ Gastrite fundique
- ✓ Pan gastrite a prédominance Antrale ou fundique

- Description des lésions ++

- ✓ Œdème ;érythème; érosions; exsudat
- ✓ Hypertrophie des plis; aspect nodulaire
- ✓ Visibilité des vaisseaux; points hémorragiques

Histologie

- Topographie:

- Morphologie:

- ✓ Catégories: aiguë; chroniques; spéciales
- ✓ Grades: légère; modérée; sévère
(inflammation; activité; HP; atrophie; métaplasie)

- Étiologie:

- ✓ Causes évidentes
- ✓ Associations pathogéniques
- ✓ HP +++

Protocole de prélèvement Au min 05 biopsies: (2 antrales, 2 corps gastrique et 1 angle de la petite courbure)

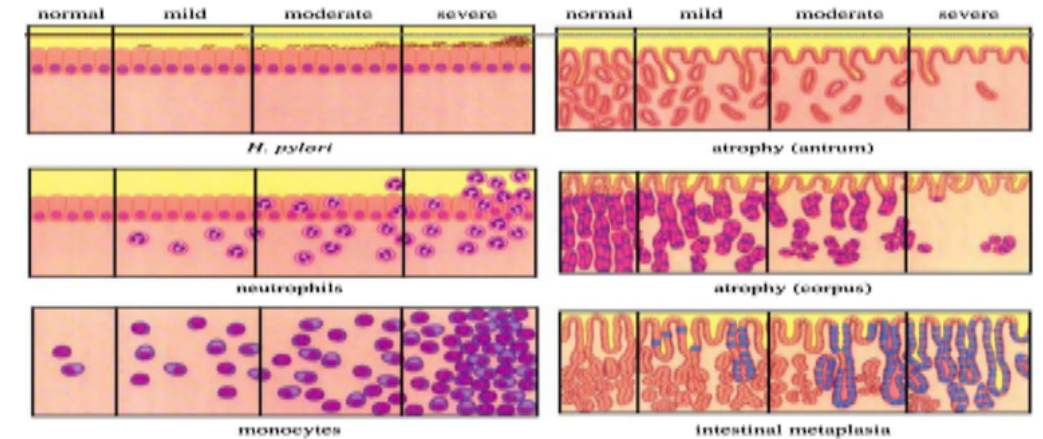
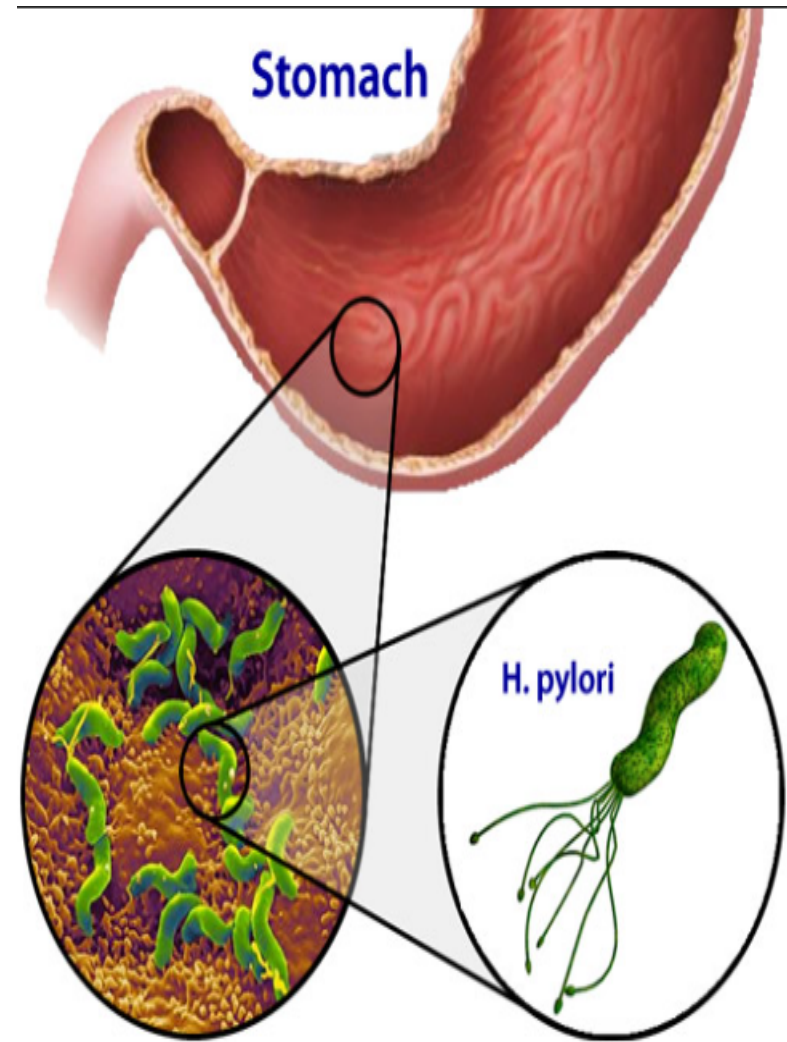


Figure 42 : Echelle de gradation visuelle élaborée par les membres du groupe de la classification Sydney révisée (32)

- **II-ETUDE DES DIFFERENTES FORMES DES GASTRITES CHRONIQUES**

- **1-Gastrite chronique liée à l'HP :**

- ***Hélicobacter Pylori (HP)** = bactérie (BGN), spiralée, avec des flagelles , présente à la surface de la muqueuse gastrique, est capable de survivre et de persister en dépit de l'acidité gastrique et d'une forte réponse immunitaire.
- Généralement acquise dans l'enfance, avant 5ans.
- Contamination interhumaine : transmission féco-orale ou oro-orale.
- Colonisation spécifique de la muqueuse de l'estomac (réservoir exclusif de la bactérie) avec **sécrétion d'uréase** :
 - o Transforme l'urée en ammoniac et en CO₂
 - o Permet une alcalinisation du microenvironnement favorable de la survie de la bactérie



- **Diagnostic de l'HP**

- **Méthodes directes et invasives** = à partir des biopsies :

- Examen histologique (coloration crésyl violet)
- Test rapide de l'uréase (ou CLO test)
- Culture des biopsies
- Amplification génique de l'ADN de *Helicobacter pylori* par PCR

- **Méthodes indirectes** = non invasives :

- Sérologie: titrage IgG *H. pylori*
- Test respiratoire de l'urée marquée au carbone C13 (breath test => contrôle de l'éradication +++)
- Détection d'antigènes dans les selles :

Histoire naturelle de l'infection à HP

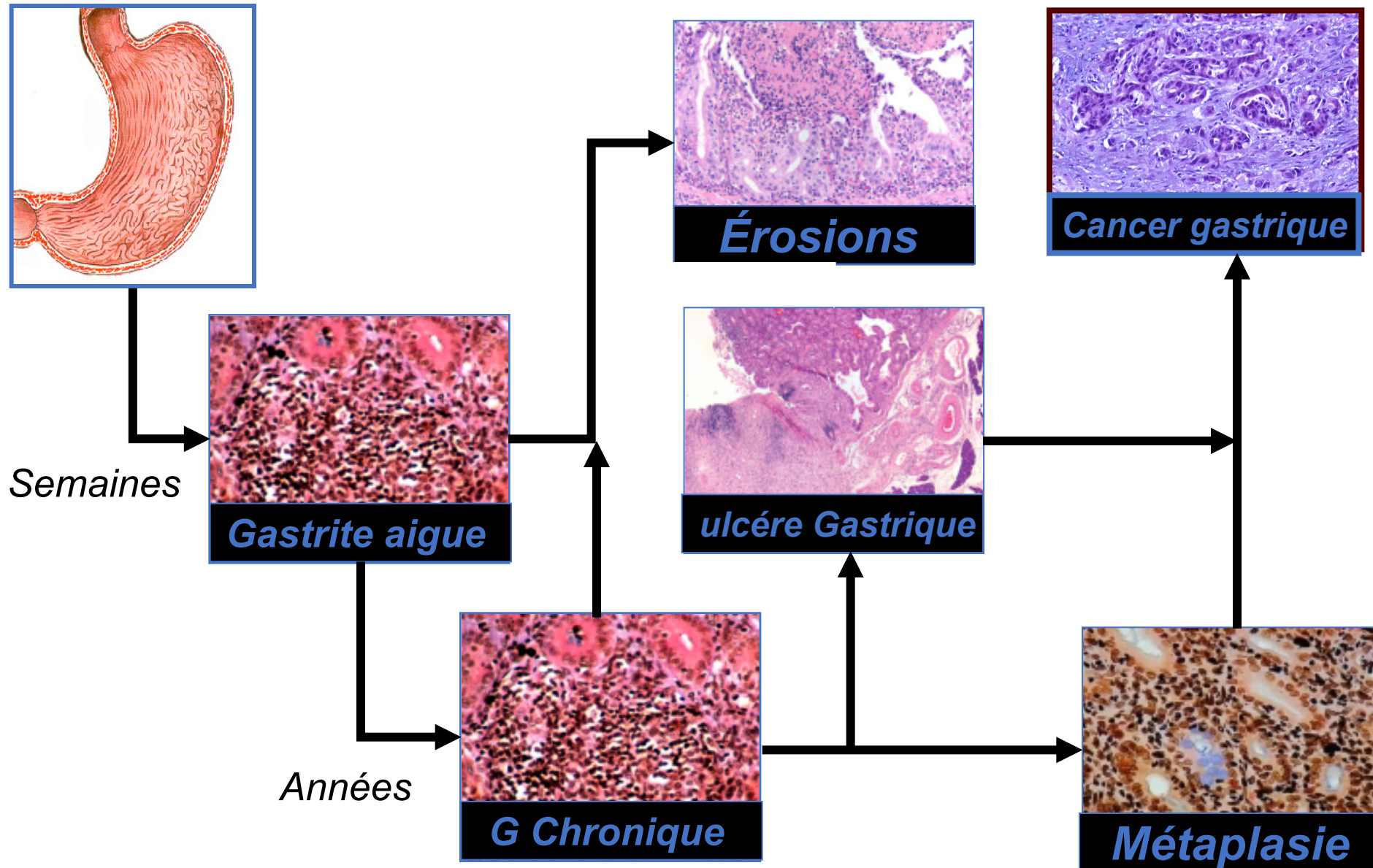
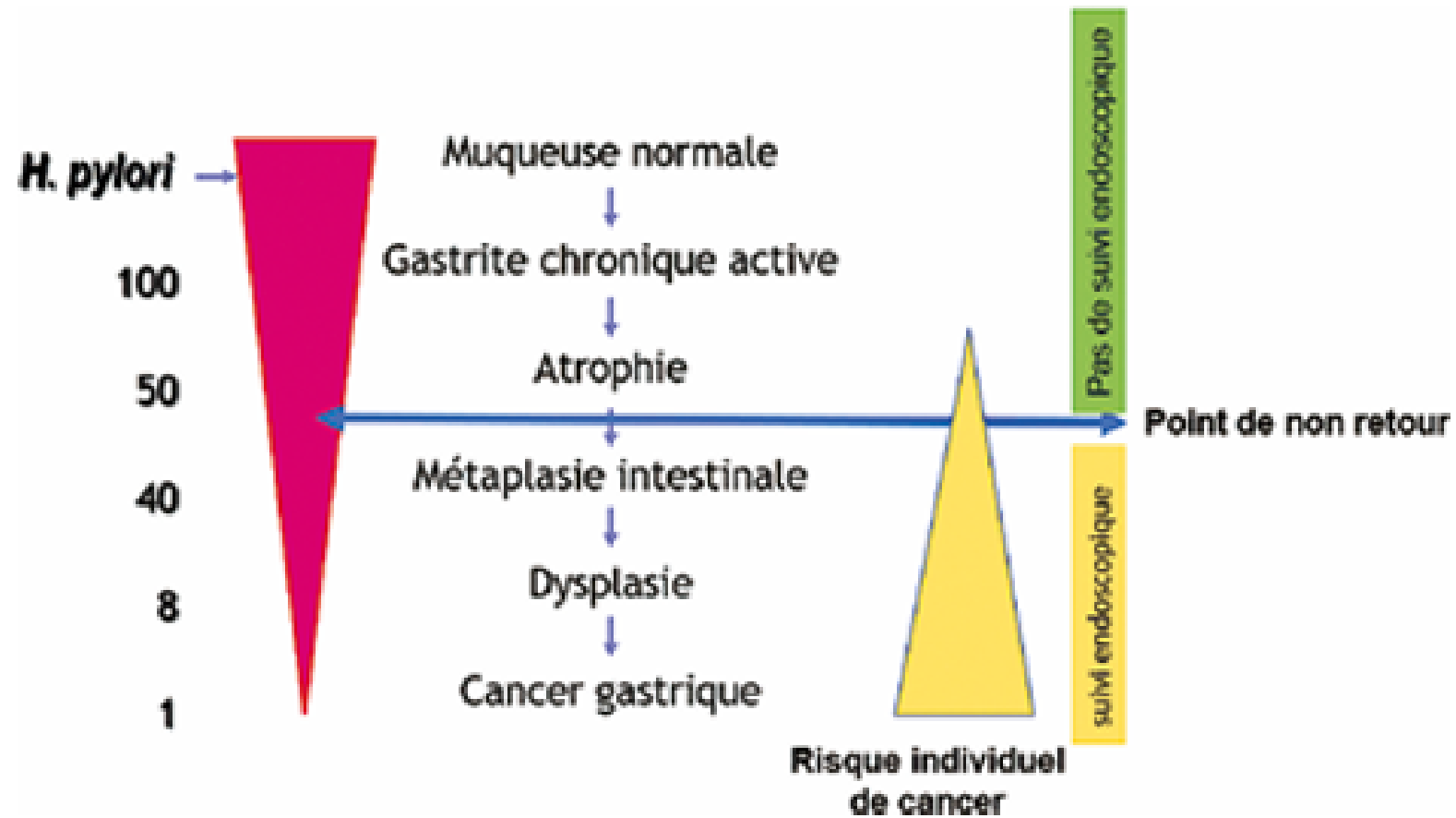


Figure 4 : Cascade des anomalies histologiques gastriques et risque individuel de cancer, en pourcentages



- *L'infection à HP peut être responsable de 2 types de gastrite :
- **a-Gastrite à prédominance antrale**
- Elle est associée à une hypersécrétion acide.
- Histologie : infiltrat inflammatoire fait de lymphocyte, plasmocytes et des PNN avec présence de follicules lymphoïdes
- Il existe un risque d'ulcère duodénal (dû à l'hypersécrétion acide) et de lymphome (à partir des follicules lymphoïdes)
- **b-Gastrite atrophique multi-focale (diffuse antrale et fundique) :**
- Elle est associée à une hyposécrétion acide.
- Histologie: atrophie gastrique progressive avec une métaplasie intestinale.
- Les lésions sont maximales au niveau de l'angle de la petite courbure.
- -Il existe un risque d'ulcère gastrique et d'adénocarcinome

- *Risque de carcinogénèse selon la séquence :
- Infection HP---Gastrite chronique atrophique---métaplasie intestinale--dysplasie—ADK
- *Traitement : traitement d'éradication de l'HP

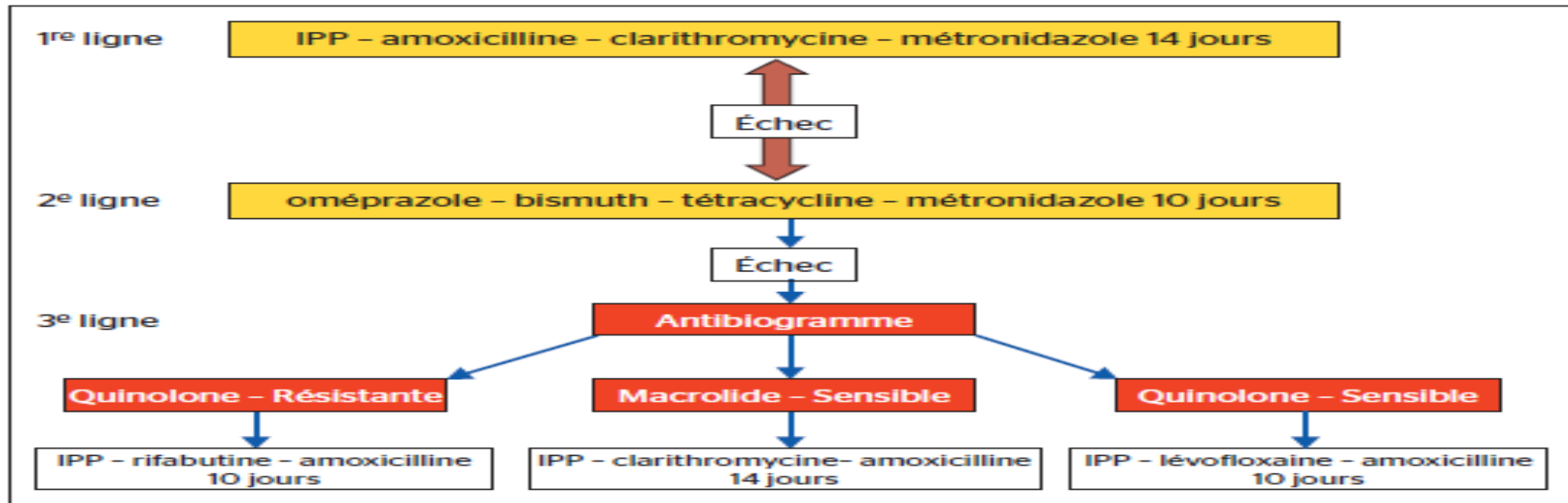


Figure 3. Algorithme de traitement de l'infection à *H. pylori* :
2 quadrithérapies interchangeable en 1^{re} et 2^e lignes,
avec le traitement concomitant ou la quadrithérapie avec bismuth

Recommandations françaises du GEFH : deux alternatives en traitement probabiliste

Pylera* : quadrithérapie bismuthée

Bismuth – Métronidazole - Tétracycline (3 gél x 4/j)
Oméprazole 20 mg x 2/j
pendant **10 jours**

Quadrithérapie concomitante

Amoxicilline 1g x 2/j +
Clarithromycine 500 mg x 2/j +
Métronidazole 500 mg x 2/j
+ IPP (rabéprazole 20mg / ésooméprazole 40 mg) X 2/J
pendant **14 jours**



- **Le contrôle d'éradication est impératif**

Les schémas d'éradications de première ligne ont une efficacité proche de 90 %.

Dans 10 % risque échec !

Un contrôle d'éradication « **au minimum 4 semaines sans prise d'antibiotique ou 2 semaines sans IPP** » est indispensable habituellement par **test respiratoire** quand il n'y a pas d'indication de gastroscopie.

- **En cas d'échec :**

- En cas d'échec d'un premier traitement probabiliste : utilisation de la QT non utilisée ou discussion d'une endoscopie pour proposer un traitement orienté.
- En cas d'échec d'un traitement orienté : traitements ultérieurs guidés par les données de la culture++

2. Gastrites chroniques non liées à HP

- a- Sans lésion spécifique :

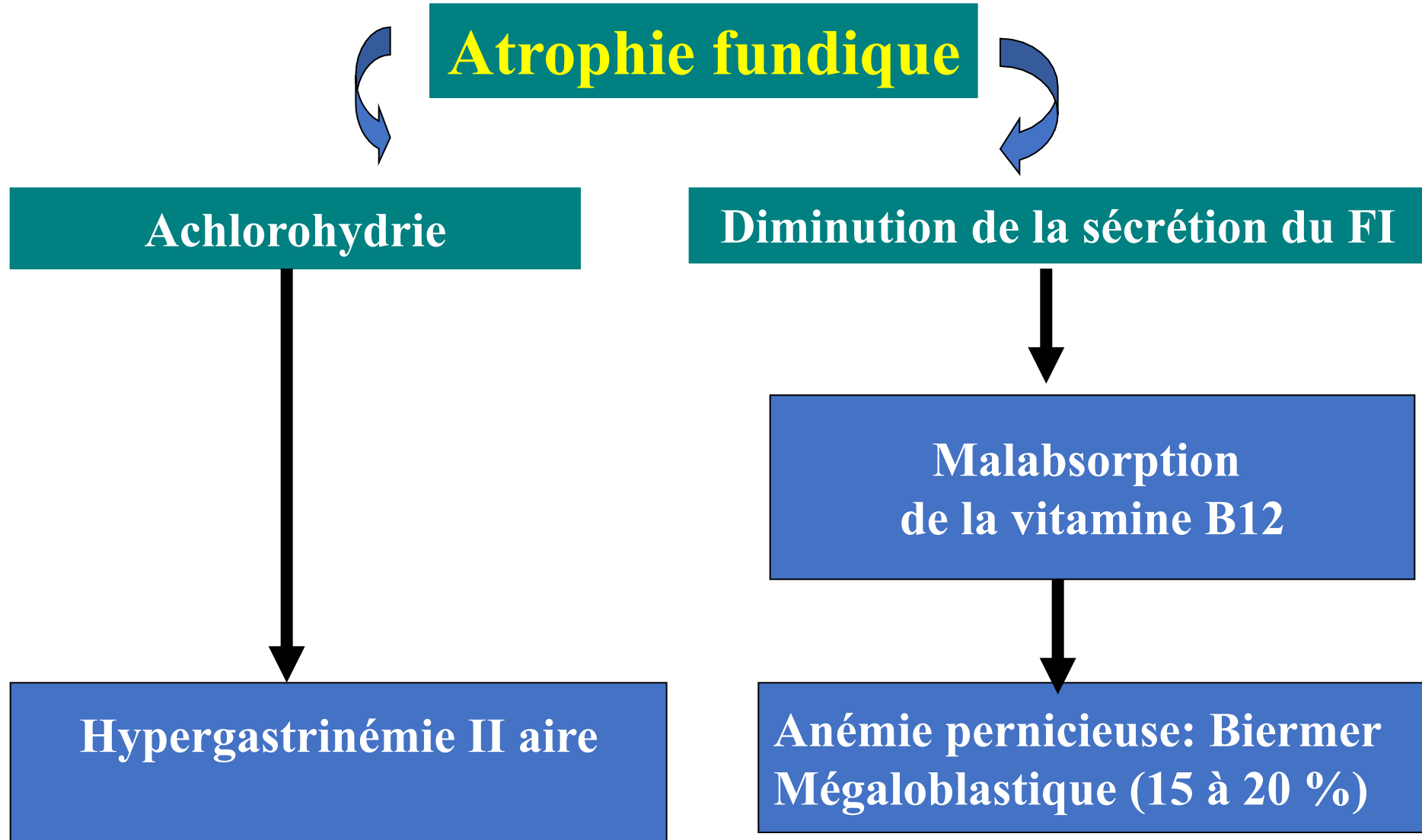
- Gastrite atrophique fundique.
- Gastrite chronique réactionnelle.

- b- Avec lésion spécifique :

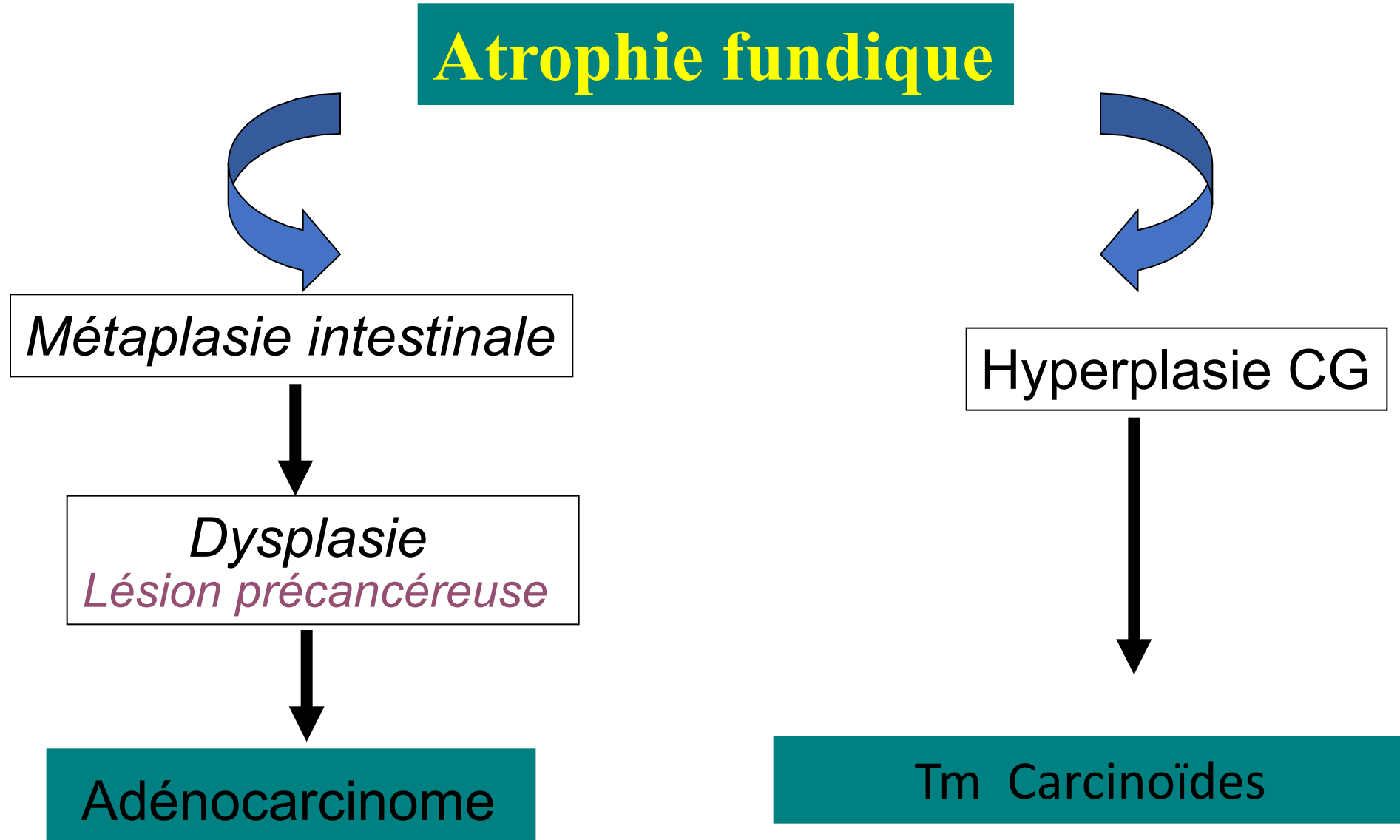
- Granulomateuse.
- Lymphocytaire.

- **a-Sans lésion spécifique :**
- **-Gastrite atrophique fundique = GC auto-immune = maladie de Biermer**
- Destruction auto-immune des glandes avec Infiltrat lympho-plasmocytaire et nodules lymphoïdes dans la couche profonde
- Atrophie des glandes fundiques remplacée par une métaplasie intestinale.
- Atteinte diffuse du corps de l'estomac avec respect relatif de l'antrum

❖ Conséquences physiopathologiques



❖ Conséquences anatomopathologiques



❖ Conséquences clinique

Anémie pernicieuse: maladie de Biermer



Clinique



Biologie

➤ Syndrome cordonal postérieur

- ✓ Trouble sensibilité profonde
- ✓ Paresthésies

➤ Syndrome pyramidal

- ✓ Déficit moteur des M<
- ✓ Signe de Babinski

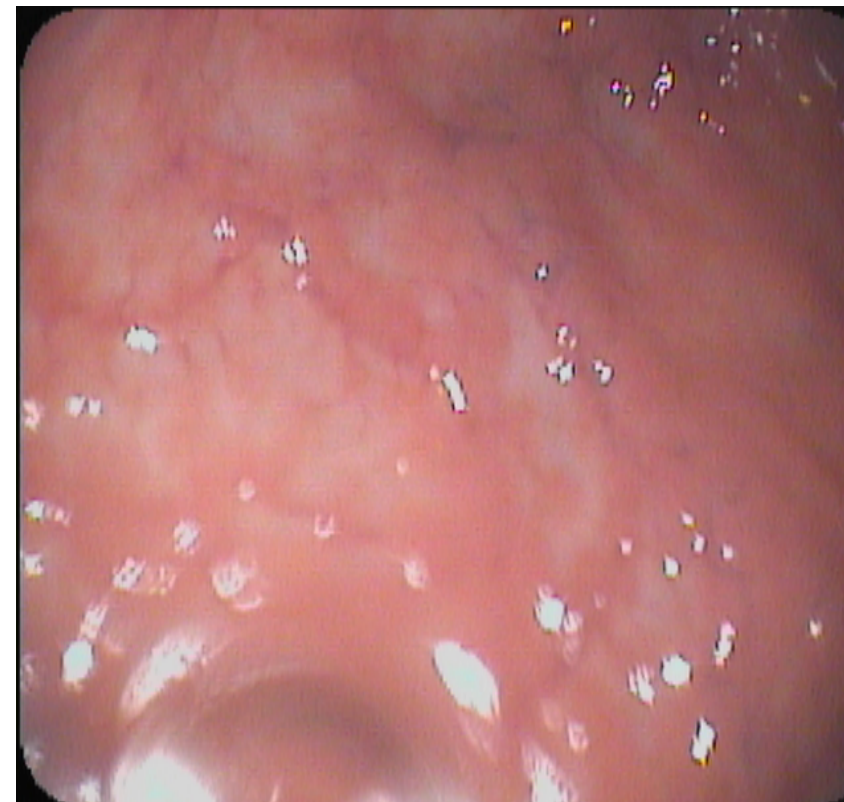
➤ Hématologie:

- ✓ Anémie macrocytaire± leucopénie et/ou thrombopénie
- ✓ Vit B₁₂ sérique basse
- ✓ MO: Mégaloblastes

➤ Immunologie:

- ✓ Ac anti cellules parietales (+)
- ✓ Ac anti facteur intrinsèque (+)

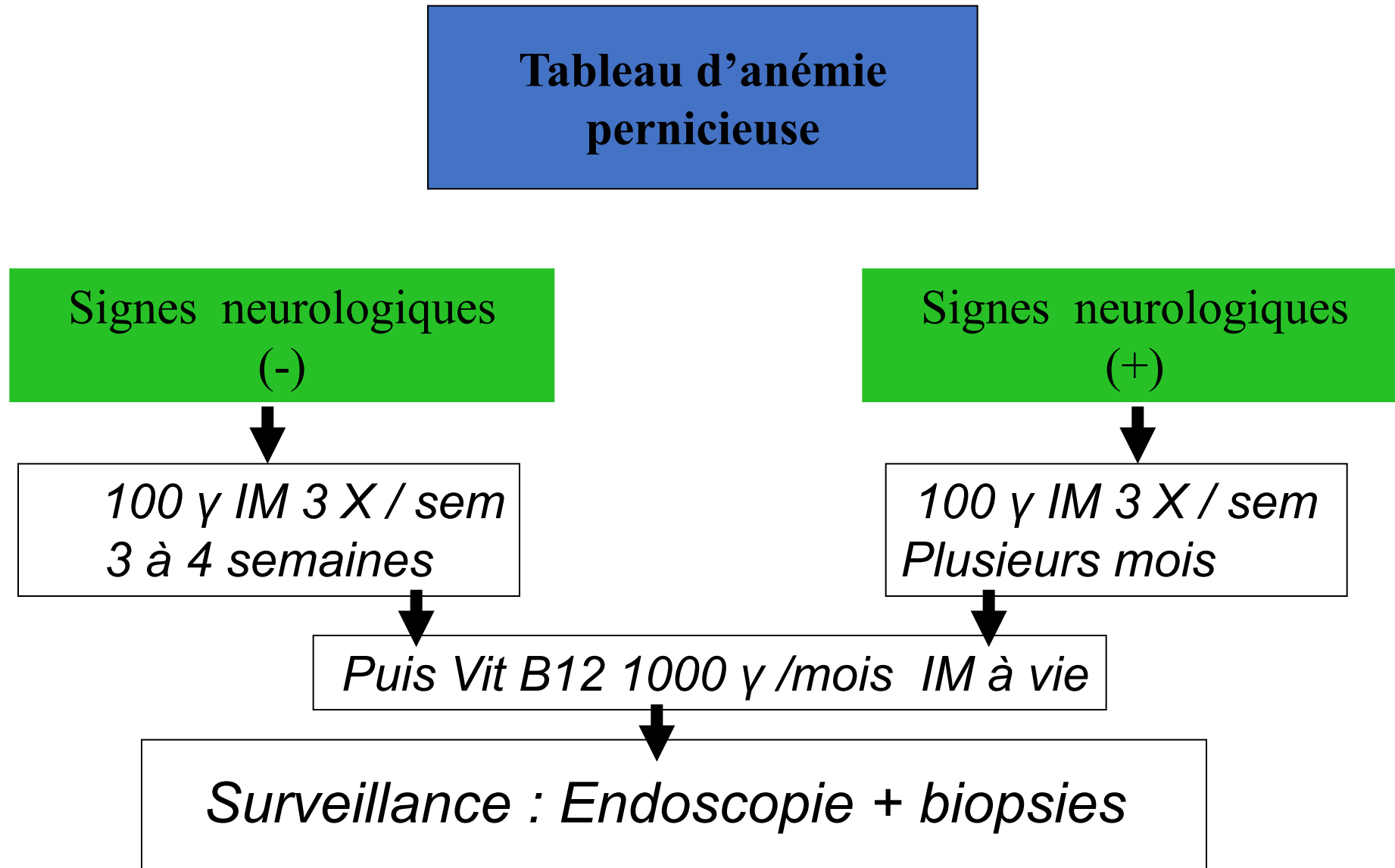
Maladie de Biermer



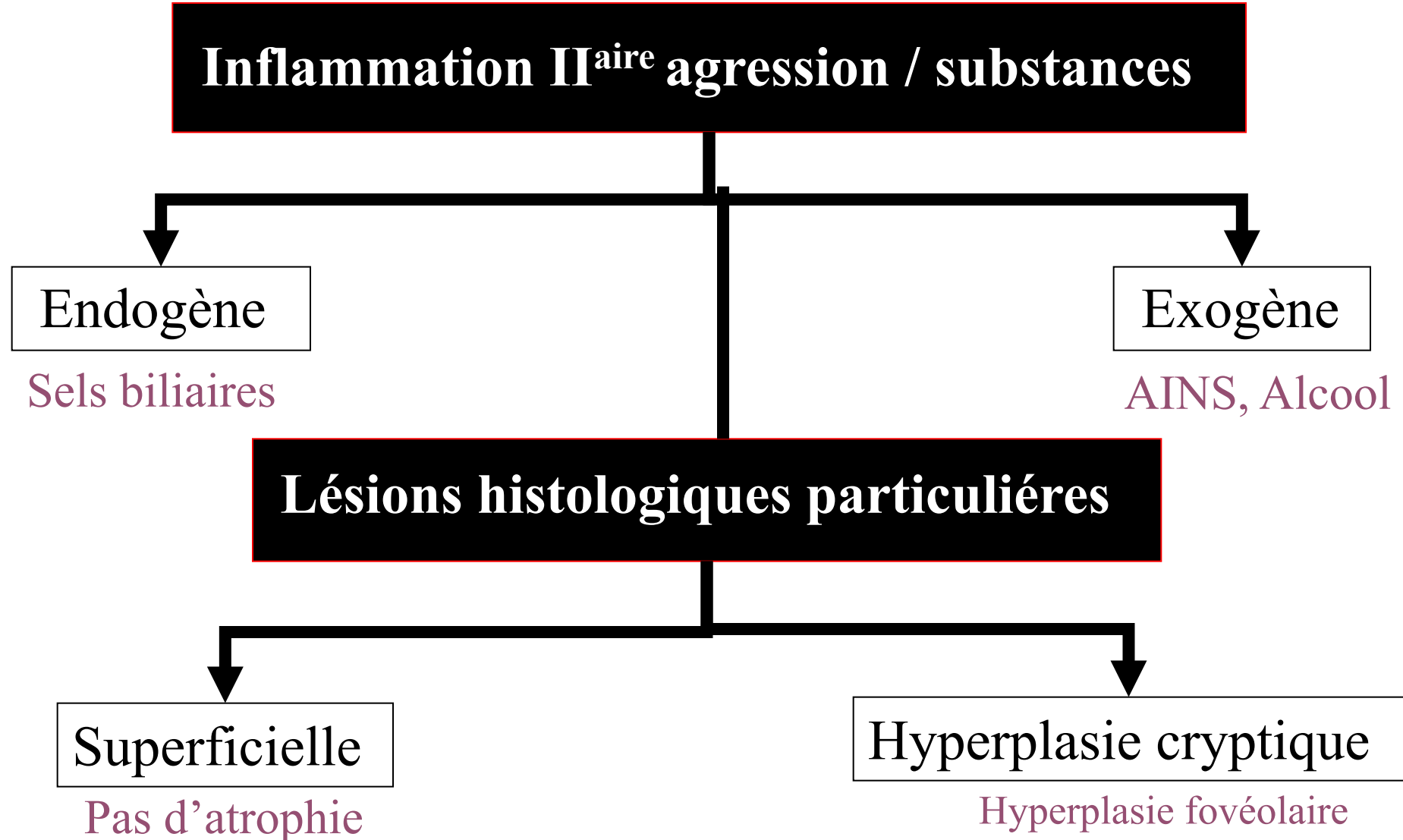
Name: ANTRI
ID: ANTRI= AINS Age: 60 Sex: M
Comment: AINS= ATROPHIE GAST

Doctor: SALAH
Date: 2005/07/20 17:23:16

❖ Traitement et surveillance



Gastriques chroniques réactionnelles



b- Gastrites chroniques avec lésion spécifique

Gastrite lymphocytaire

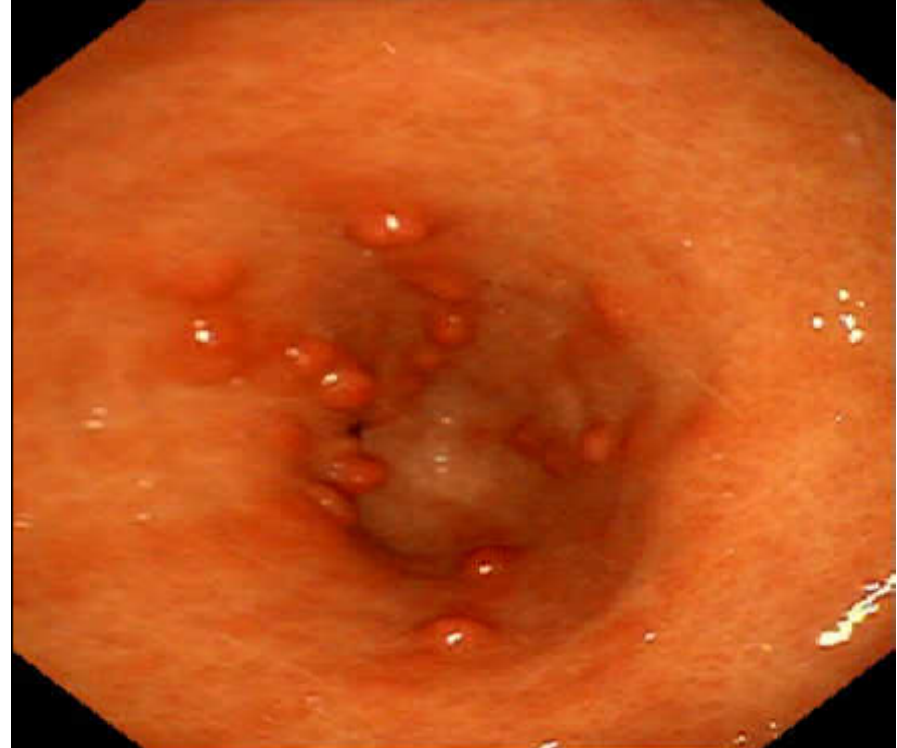
- C'est la présence d'un **infiltrat lymphocytaire** dense dans l'épithélium de surface et des cryptes avec un nombre de **LIE > 25%** de cellules épithéliales
- Endoscopiquement : aspect de gastrite varioliforme(lésion nodulaire omboliquée et érosive du corps gastrique)
- Toujours rechercher une maladie cœliaque associée
- Traitement : IPP

Gastrites Granulomateuse

Présence dans le chorion de **granulome** avec cellules **épitheloides** et parfois cellules **géantes**.

- Les étiologies sont nombreuses :
- Infectieuses (Bactériennes « BK », virales, parasitaires ,mycosiques)
- Non infectieuses (Inflammatoire « Crohn, sarcoidose », tumorales, corps étranger)

Gastrite varioliforme lymphocytaire



Autres gastrites spécifiques

- Gastrite éosinophile:
 - ✓ Rare; au cours de la gastroentérite à éosinophile (Grêle)
 - ✓ Terrain d'allergie: 50 à 70%
 - ✓ Enfants
- Gastrite collagène:
 - ✓ Très peu des cas ont été décrits
 - ✓ Signification et cause inconnue

V.CONCLUSION

- Les gastrites sont une entité histologique et non clinique ou endoscopique
- Le Diagnostic positif repose sur l'endoscopie avec biopsies
- Les étiologies les plus fréquentes :
gastrites à HP et gastrite auto-immune
- Certaines gastriques exposent au risque de cancer nécessitant une surveillance endoscopique et histologique